

Déroulé minuté de la leçon probatoire — v2 enrichie

HETS Genève · 5 juin 2026 · 40 min + 20 min de questions

Pierre Brasseur

DÉROULÉ MINUTÉ DE LA LEÇON PROBATOIRE — v2

HETS Genève — 5 juin 2026 — 40 min + 20 min de questions

Titre de la séance : « *Du protégé au sujet de droits : transformations du champ du handicap et nouvelle posture du travail social* »

Positionnement : séance 4 d'un module de spécialisation Bachelor « *Handicap, autonomie et travail social* » (orientation éducation sociale principalement, ouvert aux trois orientations). Pré-requis : 3 séances introductives sur l'histoire du travail social, la sociologie du handicap (Stiker, Ville-Fillion-Ravaud) et le cadre normatif suisse (LAI, LHand).

Public visé : 25-40 étudiant-es de Bachelor TS, semestre 4. Trois orientations représentées : service social, éducation sociale, animation socioculturelle.

Objectifs d'apprentissage (alignés PEC20) : 1. Identifier les quatre principaux modèles théoriques du handicap (médical-réadaptatif, social, MDH-PPH, droits + capacités) et reconnaître leurs effets sur la pratique professionnelle. [PEC20 C1, C7] 2. Mettre en relation les transformations contemporaines (désinstitutionnalisation, autodétermination, financement orienté personne, école inclusive) et le cadre normatif suisse (CDPH, observations ONU 2022, Initiative pour l'inclusion). [PEC20 C2, C5] 3. Nommer trois tensions de posture professionnelle et les analyser avec les outils de la clinique de l'activité (Clot), de la street-level bureaucracy (Lipsky) et de l'éthique du care (Tronto). [PEC20 C8, C9, C11] 4. Mobiliser un cas concret (vignette de Léa) pour articuler théorie et pratique en formation pratique. [PEC20 C3, C4]

DÉROULÉ DÉTAILLÉ ENRICHI

0-5 min — Accroche par la vignette-dilemme

Contenu. Lecture à voix haute de la situation :

« Léa, 22 ans, trisomie 21, vit à L'Atelier, dispositif d'accompagnement des jeunes adultes géré par la Fondation Ensemble à Genève. Un matin, en réunion d'équipe, son éducatrice référente rapporte : « Léa m'a dit : Je veux un appartement à moi et un amoureux qui dort là. » La mère de Léa, qui vient chaque week-end, demande à l'équipe de la raisonner. »

Annonce du plan en 4 temps (modèles □ transformations □ tensions □ retour à la vignette).

Posture. Accueil + énigme. Voix calme, lente, regard parcourant la salle. Ne pas donner la réponse.

Activité. Question rhétorique : « *Que feriez-vous, vous, si Léa vous disait cela demain en formation pratique ?* » Pas de réponse demandée.

Supports. Slide 1 (titre) · Slide 2 (plan) · Slide 3 (vignette intégrale) · Slide 4 (3 questions à garder).

5-8 min — Pourquoi parler de « modes d'intervention » ?

Contenu. Le lexique compte. « *Prise en charge* » suppose une personne objet ; « *modes d'intervention* » suppose un sujet et des choix professionnels. C'est l'intuition que Stiker (1982) formule en montrant que la **réadaptation moderne** « ramène à la norme, à l'identique, et désigne par là même comme différent ». Sortir de ce paradoxe suppose de cartographier les modèles du handicap.

Posture. Enseignant qui justifie ses choix de mots.

Supports. Slide 5 : tableau comparatif lexical (prise en charge / accompagnement / intervention / soutien).

8-13 min — Les modèles du handicap (1) : médical, social, MDH-PPH

Contenu.

(a) Modèle médical-réadaptatif. Origines fin XIX^e – milieu XX^e. Le handicap = déficience individuelle à corriger. Stiker (1982/2013) : « *Réadapter, c'est ramener à la norme, à l'identique* ». Posture : le TS comme *technicien de la conformité*.

(b) Modèle social britannique (Oliver 1990, UPIAS 1976). Distinction *impairment* (incapacité corporelle) / *disability* (handicap social, produit des barrières). Citation fondatrice : « *Disability is something imposed on top of our impairments by the way we are unnecessarily isolated and excluded from full participation in society* » (UPIAS 1976, repris Oliver 1990, p. 11). Posture : le TS comme *acteur du changement environnemental*.

(c) MDH-PPH / RIPPH (Fougeyrollas 2010). Modèle francophone québécois. « *Le handicap n'est pas une caractéristique de la personne mais le résultat contextuel d'une interaction* » (Fougeyrollas 2010). Métaphore du funambule : la personne avance sur un fil (habitudes de vie) tendu dans une toile (environnement). Posture : le TS comme *évaluateur situationnel*. Manon Masse et son équipe HETS l'ont mobilisé dans *Accessibilité et participation sociale* (Éditions ies 2018) pour analyser 47 institutions romandes et environ 7 000 adultes avec DI.

Posture. Didactique mais conversationnelle. Marquer chaque modèle par une posture du corps (3 places dans la salle).

Micro-interaction (1 min à 11 min). « *Levez la main : à quel modèle pensez-vous que correspond le fonctionnement de votre lieu de formation pratique actuel ?* » Comptage rapide.

Supports. Slide 6 (médical) · Slide 7 (social UPIAS-Oliver) · Slide 8 (MDH-PPH, schéma RIPPH).

13-18 min — Les modèles du handicap (2) : droits humains et capacités

Contenu.

(d) CDPH ONU 2006. Ratifiée par la Suisse le 15 avril 2014, en vigueur 15 mai 2014. Article 12 (capacité juridique universelle), article 19 (vie autonome et inclusion dans la communauté), article 24 (éducation inclusive). Préambule : « *le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales* » (CDPH, Préambule, e).

(e) Approche par les capacités (Nussbaum 2006). Critique du contractualisme rawlsien : il échoue à penser la justice envers les personnes lourdement handicapées car il présuppose des contractants libres et productifs. Dix capacités centrales garanties à chacun — dont l'affiliation, le jeu, le contrôle de son environnement. « *A life worthy of human dignity* » est garantie quand la société assure ce seuil.

Posture : le TS comme *garant de droits et facilitateur de capacités*.

Posture pédagogique. Solennelle pour la CDPH (texte juridique). Décliner les articles avec lenteur. Lecture brève à voix haute de l'art. 19 (3 lignes).

Supports. Slide 9 (CDPH art. 19) · Slide 10 (10 capacités centrales de Nussbaum).

18-19 min — Micro-interaction : retour à la vignette

Question. « Si on revient à Léa, à quel modèle se rattache la mère qui demande de la “raisonner” ? Et l’équipe qui se demande quoi faire ? »

Posture. Écoute, valorisation des contributions. Noter au tableau les hypothèses. Ne pas trancher.

19-23 min — Transformations (1) : désinstitutionnalisation

Contenu.

Cadre normatif : article 19 CDPH. **Observations finales du Comité ONU CDPH sur la Suisse, 13 avril 2022** (CRPD/C/CHE/CO/1) : 80+ recommandations. § 41 : « *The Committee is concerned about the lack of a comprehensive deinstitutionalization strategy* ». § 42 : « *adopt a deinstitutionalization strategy with a clear time frame* ».

Initiative populaire « Pour l’inclusion » : 107 910 signatures validées sur 109 110, déposée 5 septembre 2024. **Contre-projet du Conseil fédéral, message du 25 février 2026** — jugé en-deçà des attentes du comité d’initiative par Inclusion Handicap et AGILE.CH.

Genève : **plan cantonal de mise en œuvre CDPH, volume 1, janvier 2023 ; avant-projet de Loi sur l’égalité et les droits des personnes handicapées (LED-H)** en consultation depuis le **12 juin 2024**, co-construit avec une quarantaine d’organisations.

Précision critique (Mansell & Beadle-Brown 2010, position IASSIDD). « *Community-based services are typically associated with better outcomes than institutional provision, but outcomes vary widely depending on how services are organised* » (p. 106). La désinstitutionnalisation n’améliore la qualité de vie qu’à condition d’un investissement substantiel dans les services communautaires. **ENIL** documente que des fonds structurels européens continuent à financer la rénovation d’institutions.

Posture. Historicisante. « *Vous n’arriverez pas sur un terrain figé : vous arriverez dans un mouvement qui a une histoire et un présent.* »

Supports. Slide 11 : frise chronologique 2006-2026.

23-26 min — Transformations (2) : autodétermination et pair-aidance

Contenu.

Théorie de l’autodétermination (Ryan & Deci 2017). Trois besoins psychologiques fondamentaux universels : autonomie, compétence, appartenance. « *Autonomy, competence, and relatedness are not just preferences but universal psychological necessities* » (p. 86).

Application au handicap (Wehmeyer 1996, Lachapelle-Wehmeyer-Shogren 2022). *Causal Agency Theory* : agir comme l’agent causal principal de sa propre vie. « *Self-determined behavior refers to volitional actions that enable one to act as the primary causal agent in one’s life* » (Wehmeyer 1996). L’autodétermination est moins un trait individuel à entraîner qu’un produit relationnel et écosystémique.

Pair-aidance et savoirs expérientiels (Jouet, Flora & Las Vergnas 2010). « *Les patients développent, au fil de l’expérience de la maladie, des savoirs spécifiques qui ne sont pas réductibles aux savoirs médicaux.* » Cartographie pionnière en francophonie.

À Genève : recherches HETS de **Manon Masse, Chloé Souesme et Yves Delessert** sur l’autodétermination, l’habitat et la pair-aidance dans le champ du handicap intellectuel. Souesme (2024, *REISO*) : « *Des pair-e-s pour faciliter l’habitat autonome* ».

Posture. Pratique. « *L’autodétermination, ce n’est pas un mot d’ordre, c’est une réorganisation du rapport pro/personne accompagnée.* »

Supports. Slide 12 : 4 dimensions de l’autodétermination + pair-aidance.

26-28 min — Transformations (3) : financement orienté personne

Contenu.

Contribution d'assistance AI, introduite le 1^{er} janvier 2012 par la 6^e révision LAI. Logique *cash-for-care* : la personne reçoit l'argent et engage elle-même ses assistant-es.

Rapport OFAS 2020, évaluation finale. Environ 2 600 bénéficiaires fin 2019 (cible initiale 3 000 dès 2012). Durée moyenne d'engagement : 41 h/semaine. **Satisfaction : 81 % de bénéficiaires satisfaits ou très satisfaits.** Rares retours en home.

Mais. Barrières administratives lourdes, pénurie d'assistants, non-extension aux mineurs et aux personnes en curatelle de portée générale (critique d'Inclusion Handicap et d'AGILE.CH).

Mise en perspective comparative. Le Bihan, Da Roit & Sopadzhyan (2019, *Social Policy & Administration*) : les politiques *cash-for-care* instituent un « *familialisme optionnel par le marché* » — risque de précarisation des aidants professionnels migrant-es. Glendinning (2008) sur les *individual budgets* anglais : « *Personalisation marks a shift from the citizen-as-recipient to the citizen-as-purchaser of care.* »

Retour à Léa. La contribution d'assistance est l'un des outils qui rendraient son projet juridiquement possible. Léa n'est pas sous curatelle de portée générale — elle est donc éligible. Encore faut-il que l'équipe sache l'orienter et que les services d'accompagnement (Cap-Contact, Pro Infirmis) soient mobilisés.

Posture. Concrète. « *Voilà ce dont on parle. C'est cet outil qui rend la demande de Léa juridiquement possible.* »

Supports. Slide 13 : contribution d'assistance AI — schéma + chiffres OFAS 2020.

28-29 min — Micro-interaction

Question. « *Parmi les transformations qu'on vient de voir, laquelle vous semble la plus difficile à incarner comme professionnel-le ?* »

Posture. Écoute. Valider la difficulté nommée.

29-33 min — Trois tensions de la posture professionnelle

Contenu.

Tension 1 — Protection / Autonomie

Concept de **dignité du risque (Perske 1972)**. « *There can be such a thing as human dignity in risk. And there can be a dehumanizing indignity in safety!* » Surprotéger nie l'humanité de la personne.

CDPH **article 12** : capacité juridique universelle. Passage du **paradigme tutélaire** (substitution de décision) au **paradigme du soutien** (*supported decision-making*).

Éthique du care comme attention située : **Tronto (2009)** déplace le care de l'éthique privée vers la philosophie politique. « *Nous sommes tous des êtres vulnérables et dépendants. Il s'agit de redistribuer la responsabilité du care, non de la concentrer sur les plus faibles.* » **Paperman & Laugier (2006)** : le care est « *tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde* » (Tronto, citée).

Tension 2 — Expertise professionnelle / Savoir expérientiel

« **Nothing about us without us** » (Charlton 1998). « *Disability oppression is a totalizing system* » — mais l'*empowerment* individuel et collectif est possible.

Pair-aidance comme figure professionnelle nouvelle. Question critique posée par **Brasseur & Rodriguez (2019, Participations)** : comment co-construire un projet d'accompagnement avec une personne concernée sans la réduire à un témoin ? « *Les personnes handicapées sont invitées à témoigner de leur expérience pendant que les valides en produisent l'analyse.* » La participation se déploie selon « *une économie inégale de la parole* ».

Tension 3 — Travail prescrit / Travail réel

Clinique de l'activité (Clot 1999, 2008). « *Le travail bien fait est ce qui permet au sujet de se reconnaître dans ce qu'il fait.* » Distinction activité réelle / travail prescrit / activité empêchée. « *Ce qui rend malade au travail, ce n'est pas le conflit, c'est l'impossibilité du conflit.* »

Street-level bureaucracy (Lipsky 1980). « *The decisions of street-level bureaucrats, the routines they establish, and the devices they invent to cope with uncertainties and work pressures effectively become the public policies they carry out* » (p. xii). Le TS est un agent de la politique publique qui exerce une *autonomie discrétionnaire*.

Lenzi & Moine (2025), Des pas de côté dans le travail social (Champ social, 272 p.) : les marges du métier comme lieu d'invention professionnelle.

Le travail émotionnel (Hochschild 1983) comme dimension invisible mais coûteuse : « *This labor requires one to induce or suppress feeling in order to sustain the outward countenance that produces the proper state of mind in others* » (p. 7).

Posture. Critique mais bienveillante. « *Vous serez en tension. C'est normal. C'est même le signe que vous travaillez bien.* »

Supports. Slides 14, 15, 16 : une slide par tension. Format citation centrale + 3 concepts clés.

33-38 min — Activité interactive : retour à la vignette

Consigne. « *En binôme, 4 minutes : choisissez l'une des trois tensions et formulez en deux phrases ce que vous diriez à Léa, à sa mère et à l'équipe. Pas de bonne réponse — une posture argumentée.* »

Restitution. 3 binômes, un par tension, 1 minute chacun.

Posture. Facilitateur. Circuler. Reformuler les réponses en renvoyant aux concepts. Si un binôme dit « *on respecte le choix de Léa* », reformuler : « *vous mobilisez la dignité du risque de Perske et l'art. 12 CDPH* ».

Supports. Slide 17 : vignette + consigne.

38-40 min — Synthèse et ouverture

Trois acquis à retenir.

1. **Les modèles du handicap ne sont pas des étapes successives** mais des **grammaires actives** qui coexistent dans une institution. Ville, Fillion & Ravaut (2020) : « *Le handicap n'est pas un donné mais un construit historique, social et politique.* »
2. **Les transformations suisses ouvrent des marges d'action concrètes** pour les TS : CDPH, contribution d'assistance, Initiative pour l'inclusion, plan cantonal genevois, avant-projet LED-H. Mais ces marges sont « **vulnérables** » au sens de Revillard (2020) : « *Les droits ne sont pas seulement ce que les textes disent, mais ce que les personnes parviennent à en faire* » — et le TS est un opérateur clé de cette effectivité.
3. **La posture professionnelle n'est pas un trait personnel** : c'est un **travail réflexif quotidien** sur trois tensions structurelles. Schön (1983) : « *Les praticiens compétents en savent généralement plus qu'ils ne peuvent en dire.* »

Ouverture. La séance suivante portera sur « *Le travail avec les proches : entre alliés, opposants et co-aidants* » — la mère de Léa nous y accompagne.

Conseils de lecture. - Ville, Fillion & Ravaut (2020), *Introduction à la sociologie du handicap*, De Boeck. - Lenzi & Moine (dir.) (2025), *Des pas de côté dans le travail social*, Champ social. - Comité ONU CDPH (2022), *Observations finales sur la Suisse*, articles 12, 19, 24.

Supports. Slide 18 : 3 acquis + lectures.

MICRO-INTERACTIONS – RÉCAPITULATIF

Moment	Type	Durée	Fonction
11 min	Levée de main	1 min	Activer l'expérience de FP
18 min	Réponse libre	1 min	Tester la compréhension des modèles
28 min	Réponse libre	1 min	Faire émerger la dimension réflexive
33-38 min	Think-pair-share	5 min	Cœur interactif de la séance

Total interactif : 8 minutes sur 40 (20 %). Active le critère (b) du jury.

CRITÈRES JURY – TRAÇABILITÉ ENRICHIE

Critère	Activation dans la séance v2
(a) Construction d'une séquence et positionnement	Positionnement explicite (séance 4 d'un module de 13). Pré-requis nommés. Objectifs alignés PEC20 (C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8, C9, C11). Articulation explicite avec la séance suivante.
(b) Transmission, communication, interaction	4 micro-interactions + 5 min de <i>think-pair-share</i> . Posture corporelle marquée par modèle (3 places). Reformulation systématique. Citation centrale par slide.
(c) Mobilisation et valorisation des connaissances scientifiques	25+ références mobilisées avec citations précises : Oliver, Stiker, Fougeyrollas, Nussbaum, Wehmeyer, Ryan-Deci, Clot, Lipsky, Tronto, Paperman-Laugier, Hochschild, Schön, Perske, Charlton, Revillard, Ville-Fillion-Ravaut, Mansell, Glendinning, Le Bihan, Jouet, Brasseur, Brasseur-Rodriguez, Masse, Souesme, Lenzi-Moine.
(d) Articulation théorie / pratique	Vignette de Léa qui ouvre, traverse (3 reprises explicites à 18 min, 26 min, 33-38 min) et clôt la séance. Trois mentions explicites de la FP. Exemple Sureaux / Fondation Ensemble / contribution d'assistance.
(e) Apports de la recherche pour les problématiques sociales (local, national, international)	Local : Masse, Souesme, Delessert, Lenzi (HETS), projet Sureaux. National : OFAS 2020, observations ONU 2022 sur la Suisse, plan cantonal genevois 2023, LED-H 2024. International : Mansell-Beadle-Brown, Wehmeyer, Le Bihan, Glendinning, ENIL, IASSIDD.

Critère	Activation dans la séance v2
(f) Connaissance du champ du handicap à Genève	Mention nominale : Fondation Ensemble + L'Atelier (vignette), Aigues-Vertes, EPI, Clair Bois, INSOS Genève (Laederach), fégaph (22 orgs), AGILE.CH, Pro Infirmis Genève, Cap-Contact, plan cantonal CDPH 2023, LED-H 2024, projet Sureaux (Codha + Ensemble), CERES, réseau Autonomie-Handicap-Dépendance HETS-GE animé par C. Lenzi.

Déroulé v2 enrichi · Pierre Brasseur · 29 mai 2026 · Citations à revérifier sur éditions utilisées avant projection.